



**ДЕРЖАВНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР  
ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З  
ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ «МЕДИЦИНА» І  
«ФАРМАЦІЯ»  
ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

| ID здобувача / Student ID |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |

| Прізвище / Surname |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                    |  |  |  |  |  |  |  |

Варіант / Variant 90

**ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ  
СКЛАДАННЯ ЄДКІ, ЕТАП 2**

**ІНТЕГРОВАНІЙ ТЕСТОВИЙ ІСПИТ  
КРОК 2**

*I день*

**Спеціальність  
«МЕДИЦИНА»**

1. Пацієнт віком 32 роки, дивлячись на малюнок на шпалерах, бачить, як лінії починають рухатися, утворюючи силуети химерних тварин. Замість люстри, що висить на стелі, бачить гігантського восьминога. Встановіть психопатологічний симптом.

- A. Деререалізація
- B. Функціональні галюцинації
- C. Зорові галюцинації
- D. Парейдолічні ілюзії
- E. Псевдогалюцинації

2. Для перевірки гіпотензивного ефекту лікарського засобу відібрано 100 людей з артеріальною гіпертензією, яким призначили прийом цього препарату. Для оцінки статистичної значущості результатів буде порівняно значення систолічного артеріального тиску до початку лікування та через тиждень після початку. Який статистичний метод потрібно використати за умови розподілу значень артеріального тиску, відмінного від нормального?

- A. Т-критерій Вілкоксона
- B. U-критерій Манна-Уїтні
- C. Критерій Ст'юдента для пов'язаних вибірок
- D. —
- E. Критерій Ст'юдента для незалежних вибірок

3. У дворічної дитини з ГРВІ гостро з'явилися хриплистість голосу та шумний вдих. Під час плачу спостерігаються: западання над- і підключичних ямок, наростання інспіраторної задишки, які в спокої у дитини зникають. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий обструктивний бронхіт
- B. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- C. Пневмонія
- D. Стороннє тіло в дихальних шляхах
- E. Гострий плеврит

4. Пацієнт віком 65 років скаржиться на персистуючу слабкість, субфебрильну температуру тіла протягом кількох останніх років, підвищену нічну пітливість. Об'єктивно спостерігається: генералізоване збільшення лімфатичних вузлів, спленомегалія. Під час пальпації лімфатичні вузли тістоподібної консистенції, безболісні. Загальний аналіз крові: гемоглобін — 106 г/л, еритроцити —  $3,5 \cdot 10^{12}$ /л, лейкоцити —  $47 \cdot 10^9$ /л, еозинофіли — 1%, паличкоядерні нейтрофіли — 8%, сегментоядерні нейтрофіли — 23%, лімфоцити — 68%, моноцити — 0%, тромбоцити —  $210 \cdot 10^9$ /л, ШОЕ — 50 мм/год. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий лімфобластний лейкоз
- B. Хронічний мієлоїдний лейкоз
- C. Хронічний лімфоцитарний лейкоз
- D. Гострий мієлоїдний лейкоз
- E. Множинна мієлома

5. Пацієнтка віком 75 років скаржиться на наявність пухлини в правій грудній залозі. Під час пальпації у лівій грудній залозі па-

тології не виявлено. У правій визначається горбисте щільне безболісне утворення, що не зміщується. Шкіра над ним має вигляд «лимонної кірки». Сосок втягнутий. Пахвові, під- і надключичні лімфатичні вузли не пальпуються. Який патологічний стан, найімовірніше, розвинувся у правій грудній залозі?

- A. Туберкульоз
- B. Дифузна кістозна мастопатія
- C. Солітарна кіста
- D. Фібroadенома
- E. Злоякісне новоутворення

6. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на запаморочення, відчуття прискореного серцебиття, задишку під час помірного фізичного навантаження. Із анамнезу відомо, що скарги турбують останні 6 місяців із поступовим погіршенням. Спостерігається у лікарів гінеколога з приводу менорагій. Об'єктивно спостерігається: ЧД — 20/хв, ЧСС — 94/хв, шкіра та склери бліді. В аналізі крові: гемоглобін — 92 г/л, еритроцити —  $3,9 \cdot 10^{12}$ /л, КП — 0,71, середній об'єм еритроцита — 70 фл, середній вміст гемоглобіну в еритроциті — 26 пг, тромбоцити —  $240 \cdot 10^9$ /л, лейкоцити —  $6,8 \cdot 10^9$ /л, паличкоядерні — 3%, еозинофіли — 0%, базофіли — 1%, сегментоядерні — 59%, моноцити — 6%, лімфоцити — 31%, ШОЕ — 38 мм/год. Який найімовірніший діагноз?

- A. Апластична анемія
- B. Гемолітична анемія
- C. В<sub>12</sub>-дефіцитна анемія
- D. Залізодефіцитна анемія
- E. Гостра постгеморагічна анемія

7. Пацієнт віком 34 роки скаржиться на появу висипу, що супроводжується незначним свербіжем. Під час огляду на шкірі волосистої частини голови виявлено папули рожево-червоного кольору, округлої форми, схильні до злиття, вкриті сріблястими лусочками. Із анамнезу відомо, що висип з'явився після перенесеного стресу. У батька пацієнта періодично спостерігаються аналогічні висипання. Який найімовірніший діагноз?

- A. Мікроспорія волосистої частини голови
- B. Атопічний дерматит
- C. Псоріаз
- D. Себорейна екзема
- E. Різнокольоровий лишай

8. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на біль, обмеження рухів у дрібних суглобах кистей, утруднене ковтання твердої їжі, загальну слабкість, сухий кашель. Об'єктивно спостерігається: шкіра кистей, передпліч, обличчя щільна, гладенька, проксимальні суглоби II-IV пальців кистей набряклі, болючі під час пальпації. Аускультативно: над легенями сухі розсіяні хрипи, межі серця зміщені ліворуч на 2 см, тони дещо ослаблені. В аналізі крові: ШОЕ — 38 мм/год,  $\gamma$ -глобуліни — 25%, СРБ — ++. Який найімовірніший діагноз?



- A. Системна склеродермія
- B. Саркоїдоз
- C. Ревматоїдний артрит
- D. Системний червоний вовчак
- E. Дерматоміозит

9. Пацієнт віком 17 років скаржиться на головний біль, біль у горлі та підвищення температури тіла. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 2-х днів. Об'єктивно виявлено: стан тяжкий, температура тіла — 38°C. Слизова ротоглотки помірно гіперемована, набрякла, спостерігаються пливчасті нашарування на мигдаликах, піднебінні, язичку, що важко знімаються. Під час пальпації встановлено: підщелпні лімфатичні вузли збільшені, підшкірна клітковина на шиї набрякла. Який найімовірніший діагноз?

- A. Інфекційний моноклеоз
- B. Паратонзиллярний абсцес
- C. Туляремія
- D. Дифтерія
- E. Гострий лімфобластний лейкоз

10. Пацієнтку віком 58 років шпиталізовано зі скаргами на виражену задишку, що виникла день тому. В анамнезі: лімфогранулематоз. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, АТ — 106/60 мм рт. ст., під час вдиху відзначається падіння систолічного АТ на 20 мм рт. ст., ЧСС — 110/хв,  $SpO_2$  — 84%, яремні вени розширені. Аускультативно: тони серця приглушені, над легенями дихання везикулярне, хрипів немає. За результатами рентгенографії ОГК виявлено: виражена кардіомегалія. Який патологічний стан призвів до погіршення стану пацієнтки?

- A. Емболія легеневої артерії
- B. Набряк легень
- C. Інфаркт міокарда
- D. Спонтанний пневмоторакс
- E. Тампонада серця

11. У пацієнта під час клінічного обстеження в сечі виявлено підвищений вміст калцієвих солей фосфорної кислоти. Його раціон харчування містить житній та пшеничний хліб, макаронні вироби, вершкове масло, олію, картопляне пюре, молоко, сир, каву, чай, відвар шипшини, кисіль зі смородини. Енергоцінність раціону відповідає енерговитратам. Які продукти потрібно обмежити в раціоні пацієнта?

- A. Молоко і сир
- B. Макаронні вироби і хліб
- C. Каву та чай
- D. Відвар шипшини і кисіль
- E. Кисіль зі смородини

12. Пацієнтка віком 18 років скаржиться на безсоння, занепокоєння, не може пити воду через виражені болючі спазми гортані. З епіданамнезу відомо, що пацієнтку вкусила за гомілку бродяча кішка. Який найімовірніший діагноз?

- A. Енцефаліт
- B. Бартонельоз
- C. Менінгіт
- D. Правець
- E. Сказ

13. Пацієнт віком 32 роки скаржиться на підвищення температури тіла до 40°C, озноб, кашель із мокротинням, кровохаркання та біль у грудній клітці під час дихання, міалгію, діарею. З анамнезу відомо, що працює у фірмі обслуговування кондиціонерів. Де кілька днів тому його колега звернувся до лікарні з такими самими скаргами. Під час рентгенографії ОГК виявлено: вогнищеві інфільтративні тіні різної форми та щільності в обох легенях. Який збудник, найімовірніше, викликав захворювання?

- A. Клебсієла
- B. Стафілокок
- C. Мікоплазма
- D. Леґіонела
- E. Пневмокок

14. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на тривалу кровотечу зі статевих шляхів. Періодично турбують серозно-кров'янисті виділення з гнильним запахом, кровоспинні засоби не допомагають. Чотири місяці тому було проведено вишкрібання порожнини матки у зв'язку з пузирним заносом. Який найімовірніший діагноз?

- A. Лейоміома матки
- B. Хоріонепітеліома
- C. Рак ендометрія
- D. Рак шийки матки
- E. Ендометріоз

15. Пацієнт віком 74 роки скаржиться на загальну слабкість, іктеричність шкіри та склер, дискомфорт у правій підреберній ділянці, схуднення на 10 кг за останні 2 місяці. Об'єктивно спостерігається: пульс — 76/хв, ритмічний, АТ — 110/70 мм рт. ст. Під час пальпації живіт м'який, дещо чутливий у правій підреберній ділянці, де пальпується, значно збільшений, напружений та безболісний жовчний міхур. Який найімовірніший діагноз?

- A. Виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки
- B. Хвороба Крона
- C. Рак голівки підшлункової залози
- D. Жовтокам'яна хвороба
- E. Гострий холецистит

16. Проводиться дослідження впливу куріння на виникнення раку легень. Для цього відібрано дві групи людей: учасники першої групи мають в анамнезі рак легень, учасники другої — ні. Після цього з'ясовують, хто з учасників зазнав впливу фактору, а хто ні. Потім розраховують необхідні статистичні показники та роблять висновки про вплив фактору на результат. Дизайн якого дослідження описано?



- A. Клінічний експеримент
- B. Випадок-контроль
- C. Когортне
- D. Екологічне
- E. Опис серії випадків

17. Пацієнту віком 33 роки встановлено діагноз: вперше діагнований інфільтративний туберкульоз верхньої частки правої легені у фазі розпаду і обсіювання, МБТ(+). Укажіть оптимальну схему хіміотерапії на першому етапі лікування в цьому разі.

- A. Ізоніазид + рифампіцин + піразинамід + етамбутол
- B. Ізоніазид + піразинамід + етамбутол + левофлоксацин
- C. Ізоніазид + рифампіцин + піразинамід + стрептоміцин
- D. Ізоніазид + рифампіцин + піразинамід + етамбутол + канаміцин
- E. Ізоніазид + рифампіцин + етамбутол

18. У новонародженого хлопчика, що народився від другої доношеної вагітності з масою тіла 3400 г, на 4-ту годину життя з'явилося іктеричне забарвлення слизових оболонок та шкіри, що швидко поширилося на тулуб та кінцівки. Об'єктивно спостерігається: дитина млява, тонус м'язів знижений, рефлекс пригнічені, відмовляється від грудей, печінка та селезінка незначно збільшені, сеча та випорожнення звичайного кольору. З анамнезу відомо, що у матері A (II) Rh (-) група крові, у батька A (II) Rh (+). Рівень білірубину в пуповинній крові у дитини в першу добу життя — 88 мкмоль/л за рахунок непрямого. Прямая проба Кумбса позитивна. Загальний аналіз крові та мазок крові без особливостей. Який найімовірніший діагноз?

- A. Геморагічна хвороба новонародженого
- B. Гемолітична хвороба новонародженого за системою ABO
- C. Гемолітична хвороба новонародженого за Rh-фактором
- D. Фізіологічна жовтяниця новонародженого
- E. Вроджений гепатит

19. Пацієнтка віком 20 років скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C, головний біль у лобній ділянці, біль в очах, світлочутливість, біль у м'язах, сухий кашель. Із анамнезу відомо, що захворіла гостро напередодні. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, обличчя гіперемоване, очі блискучі, ін'єкція склер. Пульс — 96/хв, ритмічний. Тони серця приглушені. У легенях розсіяні сухі хрипи. Слизова оболонка ротоглотки гіперемована, зерниста, судини розширені. Менінгеальних симптомів немає. За результатами загального аналізу крові виявлено: лейкоцити —  $3 \cdot 10^9/\text{л}$ , еозинофіли — 1%, паличкоядерні нейтрофіли — 6%, сегментоядерні нейтрофіли — 51%, лімфоцити — 35%, моноцити — 7%. Який найімовірніший діагноз?

- A. Пневмонія
- B. Грип
- C. Менінгококова інфекція
- D. Кір
- E. Висипний тиф

20. Пацієнту віком 44 роки встановлено діагноз: негоспітальна пневмонія. На 5-ий день перебування в стаціонарі стан пацієнта погіршився: збільшилася кількість мокротиння, воно стало гнійним, температура тіла підвищилася до 40°C. За результатами рентгенографії ОГК виявлено: у правій легені — порожнина з горизонтальним рівнем рідини. Яке ускладнення виникло в пацієнта?

- A. Інфаркт-пневмонія
- B. Гангрена легені
- C. Абсцес легені
- D. Ексудативний плеврит
- E. Бронхоекстатична хвороба

21. Пацієнта віком 32 роки шпиталізовано до лікарні в тяжкому стані. Об'єктивно спостерігається: у свідомості, шкіра бліда, холодна, вкрита липким потом, риси обличчя загострені, темні кола навколо очей, генералізовані тоніко-клонічні судоми, температура тіла — 35,5°C, пульс — 150/хв, АТ — 40/0 мм рт. ст., язик сухий. Під час пальпації живіт безболісний. Випорожнення мимовільні, водянисті, тричі було блювання «фонтаном». Який найімовірніший діагноз?

- A. Анафілактичний шок
- B. Гіповолемічний шок
- C. Септичний шок
- D. набряк головного мозку
- E. Колапс

22. Передчасно народженому хлопчику (термін гестації — 32 тижні) з дихальними розладами та диспепсичним синдромом встановлено діагноз: гемодинамічно значуща відкрита артеріальна протока. Який лікарський засіб із нижчелаведених використовують для консервативного закриття відкритої артеріальної протоки?

- A. Парацетамол
- B. Ефінефрин
- C. Вітамін К
- D. Кофеїну цитрат
- E. Простагландин Е

23. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на головний біль, слабкість, підвищену температуру тіла та біль у горлі. Об'єктивно спостерігається: помірна гіперемія слизової оболонки зів, збільшені мигдалики та всі групи лімфатичних вузлів, 1-3 см у діаметрі, щільні, еластичні, малоболісні та не спаяні між собою. Гепатоспленомегалія. За результатами аналізу крові виявлено: лейкоцитоз, лімфомоноцитоз, віроцити — 15%. Який найімовірніший діагноз?



- A. Аденовірусна інфекція
- B. Скарлатина
- C. Гострий лімфобластний лейкоз
- D. Інфекційний мононуклеоз
- E. Дифтерія

24. Пацієнт віком 48 років скаржиться на тупий біль у ділянці правого підребер'я, слабкість, втрату апетиту, гіркоту в роті. Із анамнезу відомо, що він довгий час зловживає алкоголем. Об'єктивно спостерігається: іктеричність шкіри та склер, судинні зірочки на передній поверхні грудної клітки, розширені вени передньої черевної стінки. Під час пальпації живіт здутий, вільна рідинка в черевній порожнині, печінка на 5 см виступає з-під краю реберної дуги, ущільнена, безболісна. Пальпується край селезінки. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний холецистит
- B. Хронічний гепатит B
- C. Пухлина головки підшлункової залози
- D. Вітамін B<sub>12</sub>-дефіцитна анемія
- E. Цироз печінки

25. Під час огляду дитини на 4-ту добу життя в ділянці шиї, потилиці й сідниць з'явилися пухирці з серозно-гнійним вмістом. Об'єктивно спостерігається: стан задовільний, дитина активна, рефлекс новонароджених викликаються в повному обсязі, пуговина на стадії муміфікації, пупочна ділянка без особливостей. Який найімовірніший діагноз?

- A. Флегмона
- B. Бульозний епідермоліз
- C. Пухирчатка новонароджених
- D. Піттиця
- E. Везикулопустульоз

26. Десятирічна дівчинка скаржиться на біль та набряклість колінних суглобів, підвищення температури тіла до 38,5°C, слабкість. Із анамнезу відомо, що 3 тижні тому хворіла на скарлатину. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, шкіра бліда, колінні суглоби набрякли, рухи в них болючі, обмежені. Перкуторно: межі серця зміщені ліворуч на 1,5 см. Аускультативно: тони серця ослаблені, аритмія, систолічний шум на верхівці. В аналізі крові: ШОЕ — 48 мм/год, АСЛ-О — 413 Од/мл. Який найімовірніший діагноз?

- A. Міокардит
- B. Ювенільний ревматоїдний артрит
- C. Реактивний артрит
- D. Гостра ревматична гарячка
- E. Дерматоміозит

27. Пацієнтку віком 32 роки шпиталізовано зі скаргами на напад болю у правому підребер'ї з іррадіацією в спину, нудоту, повторне блювання без полегшення стану. Із анамнезу відомо, що ці скарги з'явилися вперше 2 дні тому. За результатами УЗД ОЧП виявлено: в ділянці тіла біля шийки жовчного міхура візуалізуються 2 плаваючі конкременти діаметром 6 і 8 мм відповідно, жовчний міхур середніх розмірів, його стінки не потовщені. Після консервативного лікуван-

ня вказані симптоми регресували, загальний стан нормалізувався, пацієнтка відмовилася від пропозиції планової холецистектомії, хоче спробувати нехірургічне лікування. Який із нижченаведених лікарських засобів використовується для медикаментозного розчинення каменів у біліарній системі?

- A. Домперидон
- B. Алопуринол
- C. Урсодезоксихолева кислота
- D. Транексамова кислота
- E. Ціанокобаламін

28. Пацієнт віком 23 роки скаржиться на різкий біль у горлі ліворуч, що іррадіює в ліве вухо, неможливість відкрити рот, підвищення температури тіла до 38,8°C. Об'єктивно спостерігається: виражений тризм жувальних м'язів, асиметрія зів, лівий піднебінний мигдалик гіперемований, зміщений до середини зів, язичок зміщений праворуч, гіперемія, інфільтрація, набряклість лівої половини м'якого піднебіння, неприємний запах із рота, підвищена саливація, зацелісні лімфатичні вузли з лівого боку збільшені, болючі під час пальпації. За результатами риноскопічного та отоскопічного обстеження: без патології. Який найімовірніший діагноз?

- A. Парадонтит другого моляра
- B. Пухлина правого піднебінного мигдалика
- C. Правобічний парафарингеальний абсцес
- D. Пухлина лівого піднебінного мигдалика
- E. Лівобічний паратонзиллярний абсцес

29. Пацієнтка віком 27 років скаржиться на появу висипу в ділянці аксілярних западин. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 5-ти днів. Об'єктивно спостерігається: в ділянці аксілярних западин відзначається наявність болючих вузлів (по три з обох боків), м'якої консистенції, величиною з вишню із почервонінням шкіри в уражених місцях, з лівого боку два вузли перфоровані з утворенням отвору з наявністю гною, з правого боку — вузли зливаються між собою. Під час пальпації болючість в ділянці вузлів, загальна температура тіла підвищена до 37,5°C. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гумозні сифіліди
- B. Фурункульоз
- C. Псоріаз
- D. Гідраденіт
- E. Еритразма

30. Пацієнт віком 45 років скаржиться на порушення мовлення та ковтання, опущення повік, стало складно тримати голову. З анамнезу відомо, що стан погіршується протягом доби, під вечір. В неврологічному статусі: голова звисає на груді, мовлення гугняве, захищається під час ковтання, слабкість м'язів з обох боків, парез м'якого піднебіння. Рефлекси з м'якого піднебіння та глотковий збережені. Язик — по середній лінії, не змінений. Сухожилкові рефлекси живі, рівномірні. Парезів кінцівок не виявлено. Вранці рантрово стан погіршився: виражена



дизартрія, не ковтає, дихання утруднене, з'явився ціаноз губ. Яке ускладнення, найімовірніше, розвинулося в пацієнта?

- A. Епілептичний напад
- B. Аддисонічний криз
- C. Міастенічний криз
- D. набряк легень
- E. Холінергічний криз

31. На працівників під час виконання робіт у гірничих виробках діє мінеральний пил у вигляді аерозолів дезінтеграції. Для визначення рівня небезпеки виникнення професійних пилових захворювань вивчали хімічні та фізичні властивості пилу. Яка із властивостей пилу визначає загалом глибину його проникнення в дихальні шляхи?

- A. Вміст діоксиду кремнію
- B. Дисперсність
- C. Форма пилових часток
- D. Електрозарядженість
- E. Розчинність

32. Пацієнт віком 45 років скаржиться на гарячку, озноб, пітливість у нічний час, прискорене серцевиття, виражену слабкість протягом 2-х тижнів. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, множинні підшкірні вузлики до 3 мм на подушечках пальців рук та ніг, температура тіла — 38,5°C. Перкуторно: межі серця розширені ліворуч, аускультативно в точці Боткіна-Ерба вислуховується діастолічний шум. АТ — 110/40 мм рт. ст., ЧСС — 132/хв. Три проби посіву крові позитивні на *Staphylococcus aureus* (резистентний до метициліну). Встановлено діагноз: інфекційний ендокардит. Який лікарський засіб необхідно призначити пацієнту в цьому разі?

- A. Рифампіцин
- B. Цефтріаксон
- C. Ампіцилін
- D. Азтреонам
- E. Ванкоміцин

33. Пацієнтка віком 62 роки звернулася до лікаря на 4-й день хвороби зі скаргами на загальну слабкість, наявність яскраво-рожевої плями на шкірі лівої гомілки діаметром 10х7 см, з чіткими межами, біль у суглобах, постійний головний біль, зниження апетиту, нудоту. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 38,5°C, АТ — 130/70 мм рт. ст., пульс — 68/хв, свідомість збережена, позитивні менингеальні симптоми, ністагм, знижені черевні рефлекси. За два тижні до появи скарг відпочивала на дачі, помітила і самотійно зняла із себе кліща, по медичну допомогу не зверталася. Який найімовірніший діагноз?

- A. Кліщовий енцефаліт
- B. Сибірка
- C. Бешіа
- D. Ентеровірусна інфекція
- E. Хвороба Лайма

34. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на надмірні виділення з піхви. За результата-

ми гінекологічного обстеження виявлено: слизова оболонка шийки матки та стінок піхви звичайного рожевого кольору, виділення слизово-водянисті із «рибним запахом», тіло матки і додатки не змінені. Під час бактеріоскопічного дослідження мазків, забарвлених за Грамом, виявлено ключові клітини. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хламідіоз
- B. Гонорея
- C. Трихомоніаз
- D. Герпетична інфекція
- E. Бактеріальний вагіноз

35. У пацієнта віком 72 роки на 6-й день після планової операції раптово виникла гостра дихальна недостатність. Об'єктивно спостерігається: верхня половина тулуба, шия та обличчя ціанотичні, кашель, різкий біль за грудниною, АТ — 90/60 мм рт. ст., ЧСС — 130/хв, ЧД — 32/хв. На ЕКГ: інверсія зубця Т. Яке ускладнення виникло в пацієнта?

- A. Септичний шок
- B. Тромбоемболія легеневої артерії
- C. Інфаркт міокарда
- D. Пневмонія
- E. Гіповолемічний шок

36. У пацієнта віком 55 років за результатами рентгенографії ОГК виявлено: поодинокі вогнища малої інтенсивності зливного характеру на верхівці правої легені. В анамнезі: резекція шлунка з приводу виразкової хвороби, курить протягом 15-ти років. Скарг пацієнт не має. Аускультативно: дихання везикулярне, хрипи не прослуховуються. Перкуторно: над легенями — легеневий звук. Аналіз крові без змін. Який найімовірніший діагноз?

- A. Пневмонія
- B. Метастатичний рак
- C. Периферичний рак
- D. Вогнищевий туберкульоз
- E. Саркоїдоз

37. Пацієнту віком 28 років із гострою шлунково-кишковою кровотечею III ступеня перелито 1000 мл одногрупної консервованої еритроцитарної маси. Укажіть препарат, який необхідно застосувати під час гемотрансфузії для профілактики цитратної інтоксикації.

- A. Магнію сульфат
- B. Калію глюконат
- C. Натрію хлорид
- D. Літію хлорид
- E. Кальцію хлорид

38. Пацієнт віком 25 років скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла, появу висипання. Із анамнезу відомо, що 3 тижні тому хворів на ГРВІ. Об'єктивно спостерігається: петехіальний висип на симетричних ділянках тіла, переважно на ногах та сідницях, температура тіла — 37,4°C, АТ — 110/80 мм рт. ст. За результатами загального аналізу крові виявлено: еритроцити —



$3,2 \cdot 10^{12}/\text{л}$ , гемоглобін —  $110 \text{ г/л}$ , колірний показник —  $0,9$ , тромбоцити —  $160 \cdot 10^9/\text{л}$ , лейкоцити —  $8,7 \cdot 10^9/\text{л}$ , еозинофіли —  $4\%$ , базофіли —  $0\%$ , паличкоядерні нейтрофіли —  $7\%$ , сегментоядерні нейтрофіли —  $56\%$ , лімфоцити —  $26\%$ , моноцити —  $7\%$ , ШОЕ —  $17 \text{ мм/год}$ . Який найімовірніший діагноз?

- A. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура
- B. Гемофілія А
- C. Гострий лімфобластний лейкоз
- D. Авітаміноз С
- E. Геморагічний васкуліт

39. У пацієнта виявлено енцефалопатію, поліневропатію, порушення порфіринового обміну. У загальному аналізі крові спостерігається: базофільна зернистість еритроцитів. Функція нирок та печінки порушена. Отруєння яким металом спричинило таку клінічну симптоматику?

- A. Кадмієм
- B. Марганцем
- C. Ртуттю
- D. Свинцем
- E. Сріблом

40. У пацієнта віком 35 років виник напад, під час якого з'явилися серцебиття, озноб і страх смерті. Об'єктивно спостерігається: блідість шкіри та підвищення АТ. Напад закінчився виділенням великої кількості сечі. Який патологічний стан виник у пацієнта?

- A. Симпато-адреналовий криз
- B. Гіперглікемічна кома
- C. Колапс
- D. Епілептичний напад
- E. Тиреотоксичний криз

41. У дівчинки на 7-му добу після народження підвищилася температура тіла до  $38^\circ\text{C}$ , з'явився рясний везикулозний висип по всьому тілу та на слизових оболонках рота й піхви. З крові та вмісту везикули була виділена ДНК *Varicella-Zoster virus*. Який лікарський засіб необхідно застосувати для етіотропного лікування дитини в цьому разі?

- A. Ацикловір
- B. Доксициклін
- C. Рибавірин
- D. Метронідазол
- E. Озельтамівір

42. Пацієнт віком 30 років скаржиться на напади вираженого головного болю та стріляючого болю в ділянці обличчя. Із анамнезу відомо, що біль може виникати під час гоління зранку, провокується рухами нижньої щелепи під час їжі, локалізується в ділянці правої щоки, ока, верхньої щелепи. Об'єктивно спостерігається: різка болючість під час пальпації точки виходу з черепу другої гілки V черепного нерва праворуч. Який найімовірніший діагноз?

- A. Невралгія трійчастого нерва
- B. Мігрень
- C. Кластерний головний біль
- D. Головний біль напруги
- E. Невралгія потиличного нерва

43. Пацієнта віком 60 років шпиталізовано без свідомості. Із анамнезу відомо, що хворіє на цукровий діабет та артеріальну гіпертензію, приймає інсулін і гіпотензивні засоби. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, шкіра суха, тургор знижений, язик сухий, обкладений коричневим нальотом, тонус м'язів і очних яблук знижений, температура тіла —  $38,2^\circ\text{C}$ , пульс слабого наповнення —  $108/\text{хв}$ . Аускультативно — тони серця глухі. АТ —  $90/50 \text{ мм рт. ст.}$ , дихання часте, поверхневе. Запах ацетону відсутній. В аналізі крові: глюкоза —  $58 \text{ ммоль/л}$ , загальний білок —  $105 \text{ г/л}$ , сечовина —  $16 \text{ ммоль/л}$ , натрій —  $238 \text{ ммоль/л}$ , калій —  $5,5 \text{ ммоль/л}$ , молочна кислота —  $0,8 \text{ ммоль/л}$ . В аналізі сечі: глюкоза —  $15 \text{ ммоль/л}$ , кетонів тіла відсутні. Який вид коми, найімовірніше, виник у пацієнта?

- A. Уремічна
- B. Молочнокисла
- C. Гіперосмолярна
- D. Печінкова
- E. Кетоацидотична

44. Пацієнтка віком 65 років звернулася до лікаря зі скаргами на слабкість у лівих кінцівках, що виникла вранці та поступово наростала протягом дня. Об'єктивно спостерігається: свідомість ясна, АТ —  $190/100 \text{ мм рт. ст.}$ , ЧСС —  $80/\text{хв}$ , пульс ритмічний, систолічний шум на шії в проекції біфуркації правої загальної сонної артерії. Під час дослідження неврологічного статусу встановлено: згладженість носогубної складки ліворуч, девіація язика вліво, зниження м'язової сили в лівих кінцівках до 3 балів, сухожилкові рефлексy S>D, позитивний симптом Бабіньського з лівого боку, лівобічна гемігіпестезія. Який найімовірніший діагноз?

- A. Інфаркт мозку
- B. Гостра гіпертензивна енцефалопатія
- C. Розсіяний склероз
- D. Субарахноїдальний крововилив
- E. Прогресуюча судинна лейкоенцефалопатія

45. Пацієнт віком 50 років скаржиться на кашель із виділенням мокротиння зеленуватого кольору до  $200 \text{ мл}$  на добу, експіраторну задишку під час ходьби. Із анамнезу відомо, що симптоми турбують довгий час. Об'єктивно спостерігається: акроціаноз, грудна клітка діжкоподібна, нігті нагадують годинникові скельця. Перкуторно: над проекцією всіх легеневих полів — коробковий звук, аускультативно — дихання ослаблене, розсіяні сухі різнотемброві хрипи та великопухирчасті вологі хрипи у нижніх відділах легень. За результатами рентгенографії ОГК виявлено: деформація та посилення легеневого малюнка, тонкостінні кільцеподібні тіні. За результатами КТ ОГК: симптом «перся», симптом «трамвайної рейки». Який найімо-



вірніший діагноз?

- A. Інфільтративна форма туберкульозу легень
- B. Ехінококоз легень
- C. Бронхоектатична хвороба
- D. Кавернозна форма туберкульозу легень
- E. Абсцес легень

46. Пацієнтка віком 28 років скаржиться на безпліддя впродовж 3-х років. В анамнезі: гонорея. Об'єктивно спостерігається: розвиток статевих органів без відхилень від норми. Базальна температура протягом трьох циклів двофазна. Яка найімовірніша причина безпліддя?

- A. Аномалія будови статевих органів
- B. Ендокринний чинник
- C. Імунологічне безпліддя
- D. Ендометріоз
- E. Порушення прохідності маткових труб

47. Чотиримісячну дитину шпиталізовано зі встановленим діагнозом: стафілококова пневмонія. Із анамнезу відомо, що в дитини протягом 2-х днів немає випорожнень, гази не відходять, декілька разів було блювання шлунковим вмістом, з домішком жовчі. Об'єктивно спостерігається: живіт здутий, м'який, перистальтика не вислуховується. На оглядовій рентгенограмі органів черевної порожнини: рівномірно роздуті газом петлі кишечника, множинні чапії Клойбера невеликого діаметру. Який найімовірніший діагноз?

- A. Паралітична кишкова непрохідність
- B. Перфоративний перитоніт
- C. Странгуляційна кишкова непрохідність
- D. Обтураційна кишкова непрохідність
- E. Кишкова інвагінація

48. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на запаморочення, задишку під час незначного фізичного навантаження, загальну слабкість, підвищення температури тіла до  $37,4^{\circ}\text{C}$ . Із анамнезу відомо, що 2 тижні тому вона переохворіла на ГРВІ. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, ЧД — 26/хв, пульс — 85/хв, слабкого наповнення, АТ — 100/50 мм рт. ст. Перкуторно — межі серця розширені ліворуч і праворуч. Аускультативно: тони серця глухі, у легенях вислуховується везикулярне дихання, ослаблене в нижніх відділах. Набряків немає. Пальпується збільшена на 2 см печінка. На ЕКГ: ритм синусовий, блокада правої ніжки пучка Гіса. Який найімовірніший діагноз?

- A. Септичний ендокардит
- B. Інфаркт міокарда
- C. Гострий міокардит
- D. Гострий перикардит
- E. Пневмонія

49. Пацієнту віком 16 років проведено ревакцинацію КПК (кір, паротит, краснуха). Через 5 хв після введення вакцини в пацієнта з'явилася задишка, неспокій, пригнічення свідомості, АТ знизився зі 110/70 мм рт. ст.

до 60/40 мм рт. ст., з'явилася тахікардія — 130/хв, шкіра та слизові оболонки набули блідо-ціанотичного кольору. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

- A. Септичний шок
- B. Набряк легень
- C. Анафілактичний шок
- D. Набряк Квінке
- E. Непритомність

50. У п'ятиденної дитини кожне сечовипускання залишає на підгузках плями чорно-коричневого кольору. Зібрана сеча виявилася каламутною з осадом. В аналізі сечі: білка немає, лейкоцити — 2-3 в полі зору, еритроцити — 0-1 в полі зору. Який найімовірніший діагноз?

- A. Сечокислий інфаркт
- B. Гострий гломерулонефрит
- C. Пухлина нирок
- D. Гострий пієлонефрит
- E. Гострий цистит

51. Пацієнт віком 44 роки скаржиться на біль у правій половині грудної клітки, задишку, кашель із виділенням значної кількості гнійного мокротиння. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкіри, ЧСС — 116/хв, температура тіла —  $39,8^{\circ}\text{C}$ , права половина грудної клітки відстає в акті дихання, притуплення перкуторного звуку та ослаблення дихання з правого боку. За результатами рентгенографії ОГК виявлено: гомогенне затемнення правої половини грудної клітки. Який найімовірніший діагноз?

- A. Бронхоектатична хвороба
- B. Правобічний пневмоторакс
- C. Абсцес правої легені
- D. Правобічний ексудативний плеврит
- E. Емпієма плеври

52. Пацієнт віком 66 років скаржиться на різкий біль за грудниною, одноразове блювання, задишку, підвищення температури тіла до  $39^{\circ}\text{C}$ . Із анамнезу відомо, що 2 дні тому проковтнув фрагмент качинової кістки, зловживав алкоголем. В аналізі крові: лейкоцити —  $16 \cdot 10^9/\text{л}$ , зсув лейкоцитарної формули вліво. За результатами рентгенографії ОГК: базальний пневмофіброз, контур середостіння не чіткий. Яке ускладнення, найімовірніше, виникло в пацієнта?

- A. Гострий панкреатит
- B. Медіастиніт
- C. Абсцес легені
- D. Аневризма аорти
- E. Перикардит

53. Пацієнтка віком 35 років скаржиться на різкий біль у ділянці відхідника, виділення крові з прямої кишки після акту дефекації протягом 3-х днів. Об'єктивно спостерігається: у ділянці відхідника наявне вишпанивання ціанотичного кольору розміром до  $3 \times 4 \times 3$  см, контактено — помірна кровоточивість, під час пальпації — болючість і напруження утворення. Який найімовірніший діагноз?



- A. Випадіння прямої кишки
- B. Гострий тромбоз геморойдального вузла
- C. Поліп анального каналу
- D. Рак прямої кишки
- E. Гостра анальна тріщина

54. Батьки десятирічного хлопчика звернули увагу на загальну слабкість дитини, швидку стомлюваність, дратівливість, зниження працездатності, успішності у навчанні, небажання займатися спортом, часті застудні захворювання, кровоточивість ясен під час чищення зубів, синці на ногах і руках. Недостатність якого вітаміну може бути причиною такого стану дитини?

- A. Ретинолу
- B. Ергокальциферолу
- C. Рибофлавіну
- D. Тіаміну
- E. Аскорбінової кислоти

55. Пацієнт віком 19 років скаржиться на біль в епігастрії, нудоту, сеча набула темно-коричневого кольору. Із анамнезу відомо, що протягом 4-х днів його турбували загальна слабкість, утруднення носового дихання та підвищена температура тіла до 37,4°C. Який найімовірніший діагноз?

- A. Виразкова хвороба
- B. Інфекційний мононуклеоз
- C. Вірусний гепатит A
- D. Вірусний гепатит B
- E. Лептоспіроз

56. Під час пологів у терміні вагітності 40 тижнів народився хлопчик. Об'єктивно спостерігається: самостійне дихання відсутнє, м'язовий тонус значно знижений, приблизна маса тіла — 3500 г. Після проведення санації верхніх дихальних шляхів та штучної вентиляції легень упродовж 30 с виявлено, що ЧСС — 40/хв. Яка подальша невідкладна допомога новонародженому в цьому разі?

- A. Киснева допомога вільним потоком
- B. Непрямий масаж серця
- C. Внутрішньовенне введення епінефрину
- D. Електрична дефібриляція
- E. Продовжити лише штучну вентиляцію легень

57. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на біль унизу живота та незначні мажучі кров'янисті виділення зі статевих шляхів упродовж 3-х годин. Із анамнезу відомо, що остання менструація — 2 місяці тому. За результатами гінекологічного обстеження виявлено: тіло матки збільшене до 10 тижнів вагітності, зовнішнє вічко пропускає кінчик пальця, виділення геморагічні незначні. За результатами УЗД спостерігається: порожнина матки розширена — картина «снігової віхри». Який найімовірніший діагноз?

- A. Пухирний занос
- B. Загроза мимовільного викидня
- C. Викидень у ході
- D. Апоплексія яєчника
- E. Ендометріоз

58. У місячного хлопчика спостерігаються такі симптоми: періодичне збудження, зригування після кожного годування малими порціями молока, випорожнення нормальні за складом та об'ємом. Об'єктивно спостерігається: окружність голови — 37 см, розміри великого тім'ячка — 2,0x2,0 см, м'язовий тонус у нормі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Пілоростеноз
- B. Мікроцефалія
- C. Макроцефалія
- D. Краніостеноз
- E. Пілороспазм

59. За результатами лабораторного дослідження ґрунту виявлено: санітарне число Хлебнікова — 0,98, титр БГКП — 1,0, титр анаеробів — 0,1, яєць гельмінтів немає, личинок та лялечок мух немає. Оцініть рівень забруднення ґрунту.

- A. Чистий
- B. Відносно забруднений
- C. Забруднений
- D. Сильно забруднений
- E. Слабко забруднений

60. Десятирічний хлопчик скаржиться на м'язовий біль, утруднення під час підйому сходів та одягання. Із анамнезу відомо, що скарги з'явилися 4 місяці тому, але останнім часом відзначається посилення болю у м'язах, зниження апетиту, утруднення ковтання. Об'єктивно спостерігається: набряклість обличчя, лілова періорбітальна сритема та десквамація шкіри рук і тулуба. Який найімовірніший діагноз?

- A. Системна склеродермія
- B. Системний червоний вовчак
- C. Ювенільний ревматоїдний артрит
- D. Гостра ревматична гарячка
- E. Дерматоміозит

61. Пацієнтка віком 50 років скаржиться на нестерпний свербіж шкіри, тупий біль у ділянці правого підребер'я, загальну слабкість, стомлюваність, втрату апетиту. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом останніх 3-х років, коли вперше з'явився періодичний шкірний свербіж. Об'єктивно спостерігається: шкіра темно-коричневого кольору з ділянками екскоріації, ксантеласми на повіках, незначна гепатомегалія, спленомегалія. В аналізі крові: загальний білірубін — 68 мкмоль/л, прямий — 36 мкмоль/л, холестерин — 8,2 ммоль/л, збільшений рівень лужної фосфатази та  $\gamma$ -глутамілтрансферази. Імунологічне дослідження крові: наявність антитілохондріальних антитіл (АМА) у титрі 1:160. Який найімовірніший діагноз?



- A. Хвороба Іценко-Кушинга
- B. Вірусний гепатит С
- C. Гемохроматоз
- D. Хвороба Вільсона
- E. Первинний біліарний цироз

62. Пацієнт скаржиться на болючу припухлість у ділянці підборіддя, загальне нездужання та головний біль. Об'єктивно спостерігається: у ділянці підборіддя гостро запалений щільний вузол конусоподібної форми. Шкіра над ним напружена, червона. Усередині вузла є виразка з прямовисними краями і некротичним стрижнем брудно-зеленого кольору. Підщелепні лімфатичні вузли праворуч збільшені і болючі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Карбункул
- B. Фурункул
- C. Піщоба трихофітія
- D. Туберкульоз
- E. Третинний сифіліс

63. У дівчинки віком 14 років раптово розвинувся напад серцебиття, який супроводжувався запамороченням, нудотою, відчуттям страху. Об'єктивно спостерігається: тахікардія — 220-230/хв без ознак застійної серцевої недостатності. На ЕКГ: ЧСС — 190-230/хв, зубці Р реєструються перед комплексом QRS, комплекси QRS нормальні, вузькі. Встановлено попередній діагноз: пароксизмальна надшлуночкова тахікардія. Проведені вагусні проби не дали позитивного ефекту. Який наступний крок у наданні медичної допомоги буде найбільш доцільним у цьому разі?

- A. Внутрішньовенне введення аміодарону
- B. Пероральне застосування нітрогліцерину
- C. Внутрішньовенне введення лідокаїну
- D. Пероральне застосування бісопрололу
- E. Внутрішньовенне введення аденосину

64. Пацієнта віком 34 роки шпиталізовано зі скаргами на гострий біль в епігастральній ділянці. Об'єктивно спостерігається: рівень свідомості за ШКГ — 13-14 балів, шкіра та видимі слизові оболонки бліді, шкіра вкрита холодним потом, температура тіла — 37,3°C, ЧСС — 120/хв, АТ — 80/40 мм рт. ст., дихання поверхневе, часте, живіт децю здутий, під час пальпації незначно болючий, випорожнення дьогтеподібні, блювання малозміненою кров'ю. У загальному аналізі крові: гемоглобін — 90 г/л, еритроцити —  $3 \cdot 10^{12}/л$ . Яке ускладнення виникло в пацієнта?

- A. Пенетрація виразки шлунка
- B. Псевдомембранозний коліт
- C. Тромбоз мезентеріальних судин
- D. Перфорація кишки
- E. Кишкова кровотеча

65. Пацієнтка віком 56 років із надмірною масою тіла скаржиться на біль у колінних суглобах, який посилюється під час ходьби, особливо сходимою, під час довгого стояння на ногах. Хворіє протягом 5-ти років. Об'єктивно встановлено: колінні суглоби дефор-

мовані, набряклі, під час руху — болючі. За результатами рентгенографії колінних суглобів виявлено: суглобова щілина звужена, субхондральний склероз, краєві остеофіти. Який найімовірніший діагноз?

- A. Реактивний артрит
- B. Подагра
- C. Ревматичний артрит
- D. Остеоартроз
- E. Ревматоїдний артрит

66. Пацієнтку віком 27 років шпиталізовано до лікарні з ознаками маткової кровотечі. Із анамнезу відомо, що протягом останніх днів вона відчувала тягучий біль у нижніх відділах живота, але до лікаря не зверталася. Пацієнтка спостерігалася в жіночій консультації з приводу вагітності (11-12 тижнів). За результатами гінекологічного обстеження виявлено: піхва заповнена згустками крові, шийка матки розкрита на 2 см, в каналі визначається напружений плодовий міхур, матка збільшена до розмірів 11-12 тижнів вагітності, напружена, виділення геморагічні, дуже ясні. Яку невідкладну допомогу необхідно надати пацієнтці в цьому разі?

- A. —
- B. Вишкрібання стінок порожнини матки
- C. Внутрішньовенне введення дексаметазону
- D. Проведення токолітичної терапії
- E. Накладання шва на шийку матки

67. Пацієнт віком 55 років скаржиться на головний біль, запаморочення, свербіж шкіри та кровоточивість із ясен. Об'єктивно спостерігається: шкіра з червоно-ціанотичним відтінком, спленомегалія. За результатами загального аналізу крові виявлено: еритроцити —  $7,5 \cdot 10^{12}/л$ , гемоглобін — 206 г/л, КП — 0,95, лейкоцити —  $10,3 \cdot 10^9/л$ , ШОЕ — 2 мм/год. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий мієлоїдний лейкоз
- B. Еритремія
- C. Лімфогранулематоз
- D. Множинна мієлома
- E. Хронічний мієлоїдний лейкоз

68. Шестирічна дитина скаржиться на головний біль, слабкість, біль під час жування. Об'єктивно виявлено: двобічне збільшення слинних залоз, що заповнюють ретромандибулярну ямку, шкіра над залозами напружена, блискуча, колір її не змінений. Температура тіла — 39°C. На слизовій оболонці ротової порожнини спостерігаються сушість, набряклість зовнішнього отвору протоку слинної залози. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дифтерія
- B. Пухлини слинних залоз
- C. Інфекційний мононуклеоз
- D. Слинокам'яна хвороба
- E. Епідемічний паротит

69. Особливого значення в безпечній системі поводження відходами ЗОЗ займають матеріали забруднення біологічними речовинами



(в т.ч. кров'ю, виділеннями пацієнтів), органічні операційні відходи та патологоанатомічні відходи. До якого класу вони належать?

- A. A
- B. C
- C. D
- D. —
- E. B

70. У шестирічної дівчинки спостерігається: відставання у фізичному розвитку, напади неспритомності, задишка, блідість шкіри, розширення меж серця та систолічне дрижання в II міжребер'ї, акцент II тону над легеневою артерією та систоло-діастолічний шум у міжлопатковій ділянці. Під час рентгенографії ОГК виявлено: посилення легеневого малюнка, кардіомегалія за рахунок лівих відділів серця, випинання дуги легеневої артерії. Який найімовірніший діагноз?

- A. Транспозиція магістральних судин
- B. Відкрита артеріальна протока
- C. Відкрите овальне вікно
- D. Терада Фалло
- E. Стеноз отвору легеневої артерії

71. Який тип лікарні спеціально організований для забезпечення гуманних, персоніфікованих та сімейно-орієнтованих установ для догляду за невиліковно хворими (паліативними) пацієнтами?

- A. Санаторій
- B. Багатопрофільна лікарня
- C. Денний стаціонар
- D. Диспансер
- E. Госпіс

72. Пацієнт віком 59 років скаржиться на біль у лівому оці та лівій половині голови, значне зниження зору лівого ока, нудоту та блювання. За результатами офтальмоскопічного обстеження виявлено: гострота зору правого ока — 1,0, лівого ока — 0,03, з корекцією не поліпшується, ВОО правого ока — 21 мм рт. ст., лівого ока — 65 мм рт. ст., у лівому оці — застійна ін'єкція, рогівка набрякла, потовщена, передня камера дрібна, зіниці розширена, на світло не реагує, очне дно не видно. Який найімовірніший діагноз?

- A. Ендоксальміт правого ока
- B. Паноксальміт лівого ока
- C. Гострий напад глаукоми лівого ока
- D. Гострий іридоцикліт лівого ока
- E. Внутрішньоочна пухлина правого ока

73. Пацієнтка віком 40 років скаржиться на порушення менструального циклу, рясні менструації протягом останнього року. Із анамнезу відомо: 1 пологи, 2 штучних абортів. Об'єктивно спостерігається: загальний стан задовільний. За результатами гінекологічного обстеження виявлено: зовнішні статеві органи розвинені правильно. Шийка матки циліндричної форми, макроскопічно не змінена. Тіло матки збільшене до 9-10 тижнів вагітності, щільне, з горбистою поверхнею, рухоме, безболісне. Придатки з обох

боків без особливостей. Виділення слизові, помірні. Який найімовірніший діагноз?

- A. Лейоміома матки
- B. Внутрішній ендометріоз
- C. Гострий ендометрит
- D. Маткова вагітність
- E. Рак тіла матки

74. Пацієнтка віком 39 років хворіє протягом 15 років. Під час обстеження повідомляє, що її мозком вже давно заволодили «злочинні вчені-фізики», які випробовують на ній різні типи психотропної зброї. Відчуває на собі вплив лазерних променів, постійно чує повідомлення, які передаються їй безпосередньо в мозок. Емоційно монотонна, періодично робить якісь записи, які нікому не показує. Свідомість ясна, формальних інтелектуально-мнестичних порушень не виявлено. Який найімовірніший діагноз?

- A. Реактивний параноїд
- B. Шизо-афективний психоз
- C. Хронічний маячний розлад
- D. Параноїдна шизофренія
- E. Іволюційний параноїд

75. Пацієнта віком 36 років шпиталізовано через 40 хв після ДТП. Об'єктивно спостерігається: пацієнт до вербального контакту не доступний, на біль реагує гримасою недоволення та згинанням кінцівок, очі не розплющує, звуки не промовляє, шкірні покриви ціанотичні, на лобі садно, дихання самостійне, ЧД — 12/хв, поверхневе, АТ — 150/90 мм рт. ст., ЧСС — 108/хв. Аускультативно: над легенями дихання ослаблене, вислуховується у всіх відділах, провідні хрипи, тони серця приглушені, ритмічні. Живіт м'який, безболісний. Яку невідкладну допомогу необхідно надати пацієнту першочергово в цьому разі?

- A. Внутрішньовенно ввести 400 мл 5%-ий розчин глюкози
- B. Непрямий масаж серця
- C. Внутрішньовенно ввести 1 мг епінефрину
- D. Інтубацію трахеї
- E. Виконати електричну дефібриляцію

76. У жінки віком 25 років після пологів посилілися хиткість під час ходьби та слабкість у ногах. Хворіє протягом 6-ти років, зазначає погіршення стану щороку восени. Об'єктивно спостерігається: жінка ейфорична, знижена критичність до свого стану, горизонтальний ністагм, високі сухожилкові рефлексії, клонус стоп, патологічні стопні рефлексії, черевні рефлексії відсутні, атаксія при пробі Ромберга, інтенційний тремор і промахування під час виконання координаторних проб. На очному дні спостерігається темпоральне збільшення дисків зорових нервів. Який найімовірніший діагноз?

- A. Бічний аміотрофічний склероз
- B. Дисциркуляторна енцефалопатія
- C. Розсіяний склероз
- D. Гострий розсіяний енцефаломієліт
- E. Міастенія гравіс



77. Пацієнт віком 38 років скаржиться на головний біль дифузного характеру, незначне запаморочення, нудоту та складність фокусування погляду. Із анамнезу відомо, що 4 год тому отримав травму у ділянці голови. Результати неврологічного огляду: черепні нерви без патології, сухожилкові рефлексі S=D, позитивний субкортикальний рефлекс Марінеско-Родовічі, моторна та чутлива сфера без патології, позитивний симптом Гуревича-Мана, в позі Ромберга — легке похитування. Свідомість ясна. За результатами комп'ютерної томографії головного мозку: без патологічних змін. Який найімовірніший діагноз?

- A. Забій головного мозку легкого ступеня
- B. Забій головного мозку середнього ступеня
- C. Струс головного мозку
- D. Дифузне аксональне пошкодження
- E. Субарахноїдальний крововилив

78. Жінка віком 27 років звернулася до жіночої консультації зі скаргами на безпліддя. Статевим життям живе в шлюбі 4 роки, вагітності не запобігає. За результатами обстеження жінки встановлено: розвиток статевих органів без відхилень від норми, прохідність маткових труб не порушена, базальна температура протягом 3-х менструальних циклів однофазна. Яка найімовірніша причина безпліддя в цьому разі?

- A. Ановуляторний менструальний цикл
- B. Імунологічне безпліддя
- C. Хронічний аднексит
- D. Генітальний ендометріоз
- E. Аномалії розвитку статевих органів

79. У пацієнтки віком 69 років через 2 тижні після перенесеної операції на органах черевної порожнини з'явився біль унизу живота і в правому стегні, підвищилася температура тіла до 38,2°C. Через добу в пацієнтки з'явився набряк правого стегна, а потім — і всієї нижньої кінцівки. Об'єктивно спостерігається: права нижня кінцівка ціанотична, пульсація на артеріях кінцівки виявляється, стегно під час пальпації болюче, рух у кінцівці обмежений, живіт м'який, болючий у правій клубовій ділянці праворуч. Синдромів подразнення очеревини немає. Яке ускладнення виникло в пацієнтки в післяопераційному періоді?

- A. Гострий клубово-стегновий венозний тромбоз
- B. Синдром Леріша
- C. Гостра емболія загальної клубової артерії
- D. Гострий тромбоз нижньої порожнистої вени
- E. Гострий мезентеріальний тромбоз

80. Проведено дослідження щодо визначення факторів ризику виникнення захворювань серцево-судинної системи серед населення. У дослідженні взяло участь 4409 дорослих громадян у віці 18-69 років. У процесі вибіркового дослідження проводилось анкетування з використанням стандартних опитувальників, визначався індекс маси тіла та

біохімічні параметри. Який вид дослідження використовується в цьому разі?

- A. Кроссекційний
- B. Вибірковий
- C. Поточний
- D. Лонгітюдний
- E. Аналітичний

81. Жінка віком 34 роки, в терміні вагітності 32 тижні, скаржиться на біль у ділянці епігастрію. Об'єктивно спостерігається: АТ — 160/90 мм рт. ст., пульс — 102/хв, матка в нормотонусі, серцебиття плода звучне, ритмічне, 164/хв. В аналізі крові: гемоглобін — 86 г/л, еритроцити —  $2,8 \cdot 10^{12}$ /л, тромбоцити —  $80 \cdot 10^9$ /л, креатинін — 120 мкмоль/л, білірубін — 32 мкмоль/л, АлАТ — 225 Од/л, АсАТ — 215 Од/л. В аналізі сечі: колір — темний, уробілін — 32 мкмоль/л. Який найімовірніший діагноз?

- A. HELLP-синдром
- B. Гастроудоденіт
- C. Анемія вагітних
- D. Помірна прееклампсія
- E. Тяжка прееклампсія

82. Пацієнта віком 37 років шпиталізовано в непритомному стані. Із анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на цукровий діабет 1-го типу протягом 10-ти років, отримує 56 ОД інсуліну на добу у двох ін'єкціях. Стан раптово погіршився вдома, з'явилася різка слабкість, пітливість, тремтіння, невиразне мовлення. Об'єктивно спостерігається: АТ — 140/90 мм рт. ст., ЧСС — 100/хв, мимовільне сечовипускання. Аускультативно: над легеньми вислуховується везикулярне дихання. Який лікарський засіб необхідно ввести першочергово пацієнту в цьому разі?

- A. Розчин глюкози 40%-ий 20-40 мл в/в
- B. Інсулін короткої дії 0,1-0,2 ОД/кг в/в
- C. Розчин глюкози 5%-ий 400,0 мл в/в крапельно
- D. Пролонгований інсулін 20 ОД підшкірно
- E. Розчин NaCl 0,9% 400,0 мл в/в крапельно

83. Жінка віком 34 роки, з терміном вагітності 38 тижнів, скаржиться на різкий біль у животі, кров'яністі виділення зі статевих шляхів. В анамнезі: помірна прееклампсія. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, пульс — 120/хв, АТ — 90/60 мм рт. ст. Під час пальпації матка напружена, болюча. Серцебиття плода відсутнє. Який найімовірніший діагноз?

- A. Передчасне відшарування плаценти
- B. Передлежання плаценти
- C. Еклампсія
- D. Дискоординована пологова діяльність
- E. Клінічно вузький таз

84. У доношеної новонародженої дівчинки на 4-ту добу життя з'явився петехіальний висип на шкірі тулуба і обличчя, гематурія, мелена. Загальний стан не порушений. З анамнезу відомо, що вагітність і пологи у матері перебігали без ускладнень. За резуль-



татами аналізу крові виявлено: подовжений протромбіновий час і час часткової активації тромбопластину, знижена активність II, VII, IX, X факторів згортання крові. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гемофілія А
- B. ДВЗ-синдром
- C. Гемолітична хвороба новонароджених
- D. Гіпопластична анемія
- E. Геморагічна хвороба новонароджених

85. У дворічної дитини спостерігаються такі симптоми: біль у животі, метеоризм, збільшення живота, розлади випорожнень у вигляді закресів і діарсії, поліфекалія та жирний пінистий кал, зниження апетиту, млявість, недостатній набір маси тіла. Із анамнезу відомо, що стан дитини погіршується після введення в раціон харчування продуктів, виготовлених із пшениці, ячменю, жита (хлібо-булочні та макаронні вироби, крупи). За результатами копрологічного дослідження виявлено: стеаторея II типу. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний панкреатит
- B. Целиакія
- C. Синдром Жильбера
- D. Лактазна недостатність
- E. Муковісцидоз

86. Пацієнт віком 55 років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, зниження апетиту, біль у животі, парастезії пальців рук і ніг, хиткість під час ходьби. Із анамнезу відомо, що він довгий час вживає спиртні напої. Об'єктивно спостерігається: іктеричність шкіри, одутлість обличчя, набряк нижніх кінцівок, гепатомегалія. В аналізі крові: гемоглобін — 92 г/л, еритроцити —  $2,2 \cdot 10^{12}/л$ , КП — 1,25, загальний білірубін — 28 ммоль/л. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий лейкоз
- B. Постгеморагічна анемія
- C. Вітамін B<sub>12</sub>-дефіцитна анемія
- D. Синдром Жильбера
- E. Залізодефіцитна анемія

87. Пацієнтка віком 23 роки скаржиться на значні гнійні виділення зі статевих шляхів із неприємним запахом, печію, свербіж у ділянці зовнішніх статевих органів протягом 3-х днів. Із анамнезу відомо, що ці симптоми з'явилися після незахищеного статевого акту. Під час піхвового дослідження виявлено: слизова оболонка піхви гіперемована, виділення значні, жовто-зелені, пінисті. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хламідіоз
- B. Мікоплазмоз
- C. Бактеріальний вагіноз
- D. Кандидозний кольпіт
- E. Трихомонадний кольпіт

88. У пацієнтки віком 47 років, дизайнера за фахом, з'явилися скарги на серцебиття, пітливість, тремор рук, біль в очах. Із анамнезу відомо, що протягом 7-ми місяців при-

ймає аміодарон, варфарин, лізиноприл, тораемід та триметазидин з приводу перистуючої форми фібриляції передсердь. Який лікарський засіб, найімовірніше, призвів до погіршення стану пацієнтки?

- A. Триметазидин
- B. Тораемід
- C. Варфарин
- D. Лізиноприл
- E. Аміодарон

89. Пацієнт віком 20 років скаржиться на головний біль, похолодання та біль у нижніх кінцівках. Об'єктивно спостерігається: добре розвинені м'язи плечового поясу, верхівковий поштовх та ліва межа відносної тупості зміщені назовні. Аускультативно: акцент другого тону серця над аортою, систолічний шум по лівому краю груднини. АТ на обох верхніх кінцівках — 150/80 мм рт. ст., у підколінній ямці праворуч та ліворуч — 100/70 мм рт. ст. На ЕКГ: гіпертрофія лівого шлуночка серця. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хвороба Такаюсу
- B. Гіпертонічна хвороба
- C. Коарктація аорти
- D. Аортальна недостатність
- E. Аортальний стеноз

90. Пацієнтка віком 76 років під час спроби обернутися відчула різкий біль у ділянці лівого стегна, після чого впала на ліве стегно. Об'єктивно спостерігається: ліва стопа ротована назовні, вкорочення правої нижньої кінцівки до 1,5 см, позитивний симптом «прилиплої п'яти», рухи в лівому кульшовому суглобі обмежені, болісні, з іррадіацією у ділянку попереку. Із анамнезу відомо, що пацієнтка довгий час приймає глюкокортикостероїди. Який найімовірніший діагноз?

- A. Підвертлюговий перелом стегнової кістки
- B. Перелом шийки стегнової кістки
- C. Перелом ацетабулярної западини
- D. Люмбоішалгія
- E. Вивих голівки стегнової кістки

91. Пацієнт віком 28 років скаржиться на періодичні напади серцебиття. Об'єктивно спостерігається: АТ — 130/80 мм рт. ст., пульс — 65/хв, тони серця не змінені. За результатами ЕКГ виявлено: вкорочення інтервалу P-Q, поява у складі комплексу QRS додаткової хвилі збудження, деформація комплексу QRS та негативний зубець R. Який найімовірніший діагноз?

- A. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- B. Блокада ніжки пучка Гіса
- C. Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія
- D. Синдром передчасного збудження шлуночків
- E. Шлуночкова екстрасистолія

92. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на слабкість, підвищення температури тіла до 38,5°C, кашель із невеликою кількістю мокротиння, утруднений вдих. Захворіла після



переохолодження 2 доби тому. Під час рентгенологічного дослідження спостерігається; локальне затемнення у нижній частці правої легені. За результатами загального аналізу крові виявлено: лейкоцити —  $14 \cdot 10^9/\text{л}$ , ШОЕ — 44 мм/год, СРБ — 140 мг/л. Який найімовірніший діагноз?

- A. Спонтанний пневмоторакс
- B. Туберкульоз
- C. Пневмонія
- D. Гострий бронхіт
- E. Бронхіальна астма

93. Пацієнт віком 35 років скаржиться на слабкість, свербіж, підвищення температури тіла до  $37,5^\circ\text{C}$ , біль у лівому та правому підбер'ї, збільшення лімфатичних вузлів. За результатами загального аналізу крові спостерігається: нейтрофільний лейкоцитоз, лімфоцитопенія, анемія, збільшена ШОЕ. Під час біопсії лімфатичного вузла виявлено: поліморфноклітинні гранулеми та клітини Березовського-Штернберга. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний мієлоїдний лейкоз
- B. Хронічний лімфоцитарний лейкоз
- C. Гострий лімфобластний лейкоз
- D. Множинна мієлома
- E. Лімфогранулематоз

94. Пацієнт віком 58 років скаржиться на запаморочення та кволість, схуд на 14 кг протягом 2-х місяців. В анамнезі зазначено: перенесений туберкульоз. Об'єктивно спостерігається: посилена пігментація шкіри, дефіцит маси тіла — 10 кг, АТ — 90/55 мм рт. ст. За результатами аналізу крові виявлено:  $\text{Na}^+$  — 117 ммоль/л,  $\text{K}^+$  — 6,4 ммоль/л,  $\text{Cl}^-$  — 116 ммоль/л,  $[\text{HCO}_3^-]$  — 27 мекв/л, глюкоза — 2,9 ммоль/л. Який найімовірніший діагноз?

- A. Надниркова недостатність
- B. Тромбоз ниркових вен
- C. Хронічний гломерулонефрит
- D. Синдром Гудпасчера
- E. Хронічна ниркова недостатність

95. Пацієнт віком 58 років скаржиться на дискомфорт та часті позиви до сечовипускання, біль у промежині з іррадіацією в калитку, підвищення температури тіла до  $38,4^\circ\text{C}$ . Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися через 1 добу після переохолодження. Трисклянковий аналіз сечі: I порція (білок — 0,33 г/л, лейкоцити — 50-60 в полі зору, еритроцити — 8-12 в полі зору), II порція (білок — сліди, лейкоцити — 10-12 в полі зору, еритроцити — 1-3 в полі зору), III порція (білок — сліди, лейкоцити — 12-14 в полі зору, еритроцити — 3-5 в полі зору, білок — сліди). За результатами УЗД: розмір нирки — 104 мм, чашково-мискова система не розширена, каменів немає, паренхіма нирок — 15 мм, сечовий міхур — стінка 3 мм, каменів не виявлено, об'єм передміхурової залози — 56  $\text{см}^3$ , гідрофільна. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий пієлонефрит
- B. Сечокам'яна хвороба
- C. Гострий простатит
- D. Гострий гломерулонефрит
- E. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози

96. Пацієнт віком 42 роки скаржиться на спрагу (випиває 8-10 л води за добу), поліурію, головний біль і загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що переніс черепно-мозкову травму. Під час обстеження патології внутрішніх органів не виявлено. За результатами аналізу крові виявлено: глюкоза — 4,5 ммоль/л,  $\text{Na}^+$  — 159 ммоль/л, осмолярність плазми крові — 305 мосм/л. У загальному аналізі сечі спостерігається: питома вага — 1,001-1,004, білок, лейкоцити — 2-3 в полі зору. Який найімовірніший діагноз?

- A. Нечукровий діабет
- B. Феохромоцитома
- C. Цукровий діабет
- D. Гострий гломерулонефрит
- E. Первинний гіперальдостеронізм

97. Пацієнт віком 28 років під час фізичних вправ знезап'як відчув слабкість, біль у правій половині грудей з іррадіацією в праве плече, задишку, прискорене серцебиття. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, тахікардія до 100/хв, ЧД — 28/хв, температура тіла —  $36,6^\circ\text{C}$ , права половина грудної клітини відстає в акті дихання. Перкуторно з правого боку високий тимпанічний звук над легеньми, дихальні шуми не прослуховуються. Який найімовірніший діагноз?

- A. Інфаркт міокарда
- B. Емпієма плевральної порожнини
- C. Абсцес легені
- D. Спонтанний пневмоторакс
- E. Медіастиніт

98. Пацієнтку віком 35 років шпиталізовано до лікарні після нападу сильного болю в животі, який виник раптово після незначного фізичного навантаження. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка нерухомо лежить на ношах, неохоче спілкується, оскільки під час розмови виникає посилення болю. Під час пальпації визначається напружений живіт та позитивні симптоми подразнення очеревини в усіх відділах живота. За результатами рентгенографії ОЧП: наявне повітря під куполом діафрагми. Який найімовірніший діагноз?

- A. Апендикулярний абсцес
- B. Гостра кишкова непрохідність
- C. Туберкульозний перитоніт
- D. Защемлення внутрішньої грижі живота
- E. Перфоративна виразка шлунка або дванадцятипалої кишки

99. Під час дослідження якості рибних консервів виявлено здуття кришок. Після натискання кришка повільно повертається у вихідне положення. Деформація стінок бля-



шанок відсутня. На їхній внутрішній поверхні — темні плями. Який вид бомбажу можна констатувати?

- А. Механічний
- В. Мікробіологічний
- С. Хімічний
- Д. Фізичний
- Е. Справжній

100. Пацієнта віком 28 років госпіталізовано на 8-й день хвороби. Захворів поступово, турбують виражена загальна слабкість, помірний головний біль, безсоння, відсутність апетиту, закреп, підвищення температури тіла до  $39,2^{\circ}\text{C}$ . Об'єктивно спостерігається: стан середнього ступеня тяжкості, пульс — 60/хв, АТ — 100/60 мм рт. ст., ЧД — 17/хв, периферичні лімфатичні вузли не збільшені, слизова оболонка ротоглотки рожева, язик обкладений, з відбитками зубів по краю, шкіряні покриви бліді, на шкірі живота поодинокі рожеолі, живіт здутий, не болючий, гепатоспленомегалія. Симптоми подразнення очеревини негативні. Який найімовірніший діагноз?

- А. Харчова токсикоінфекція
- В. Черевний тиф
- С. Малярія
- Д. Висипний тиф
- Е. Грип

101. Пацієнт віком 28 років скаржиться на біль у лівій нижній кінцівці протягом 6-ти місяців, переміжну кульгавість через 50-100 м, періодичний нічний біль. Під час огляду кінцівка бліда, холодна. Артеріальна пульсація відсутня на гоміліці. Який найімовірніший діагноз?

- А. Синдром Рейно
- В. Емболія стегнової артерії
- С. Хвороба Такаса
- Д. Облітеруючий атеросклероз
- Е. Облітеруючий ендартеріїт

102. Пацієнтка віком 45 років скаржиться на гострий біль у правій половині живота, що іррадіює в праву надключичну ділянку, підвищення температури тіла, сухість та гіркоту в роті. Із анамнезу відомо, що було неодноразове блювання, яке не приносило полегшення, появу болю пов'язує з уживанням жирної та смаженої їжі. Об'єктивно спостерігається: пацієнтка лежить на правому боці, шкіряні покриви бліді, тахікардія, язик сухий, живіт під час пальпації болючий у правій половині живота та дещо напружений у правому підребер'ї. Позитивні симптоми Ортнера, Мерфі, Кера. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гострий холецистит
- В. Правобічна ниркова коліка
- С. Гострий апендицит
- Д. Гостра кишкова непрохідність
- Е. Виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки

103. Шестирічна дитина скаржиться на підвищену температуру тіла, головний біль

і біль під час ковтання. Об'єктивно спостерігається: яскраво-червоний дрібно-крапчастий висип на гіперемованій шкірі, рясніший на боковій поверхні тулуба та в природних складках, відмежована гіперемія слизової оболонки ротоглотки, гнійний наліт на мигдаликах. Який найімовірніший діагноз?

- А. Дифтерія
- В. Скарлатина
- С. Краснуха
- Д. Інфекційний мононуклеоз
- Е. Кір

104. У дворічної дитини спостерігається значне погіршення самопочуття, різке зниження апетиту, поява нудоти та блювання без видимих причин, блідість шкірних покривів, млявість, пітливість. За результатами рентгенографії органів грудної клітки виявлено: пухлинноподібне утворення у верхніх відділах заднього середостіння з правого боку, що прилягає широкою основою до тіні хребта. Дослідження сечі на катехоламіни: збільшення незрілих фракцій катехоламінів. Який найімовірніший діагноз?

- А. Нейробластома
- В. Бронхіальна кіста
- С. Тимом
- Д. Карцинома
- Е. Лімфома

105. Пацієнт віком 35 років на виробництві отримав пошкодження м'яких тканин правого стегна. Об'єктивно спостерігається: на передній поверхні стегна рвана рана розміром 6х5 см, краї рани нерівні, зазубрені, в глибині рани згустки крові, з-під яких продовжується витікання венозної крові. Який найбільш оптимальний метод тимчасової зупинки кровотечі необхідно застосувати в цьому разі?

- А. Накладання джгута дистальніше рани
- В. Накладання тугої тиснучої пов'язки
- С. Підвищене положення кінцівки
- Д. Пальцеве притискання
- Е. Накладання джгута проксимальніше рани

106. Пацієнт віком 40 років звернувся до лікаря зі скаргами на відчуття важкості та розпирання в епігастральній ділянці після прийому їжі, блювання 1 раз на 2-3 дні залишками їжі, вживаною напередодні, втрату маси тіла — близько 10 кг за останні 2 місяці. Із анамнезу відомо, що пацієнт хворіє на виразкову хворобу шлунка протягом 5 років. Яке ускладнення виразкової хвороби виникло в пацієнта?

- А. Дуоденогастральний рефлюкс
- В. Перфорація
- С. Діафрагмальна грижа
- Д. Пенстрація
- Е. Стеноз ворота шлунка

107. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,7^{\circ}\text{C}$ , біль унизу живота, дизуричні розлади. Із анам-



незу відомо, що 3 доби тому був штучний аборт. За результатами бімануального дослідження виявлено: шийка матки циліндрична, вічко закрите, тіло матки дещо збільшене, болюче, м'яке. Придатки матки не пальпуються. Виділення гнійно-геморагічні. В аналізі крові: лейкоцити —  $10 \cdot 10^9/\text{л}$ , паличкоядерні нейтрофіли — 12%. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий цистит
- B. Ендометріоз
- C. Гострий ендометрит
- D. Пельвіоперитоніт
- E. Гострий сальпінгоофорит

108. У породіллі спостерігається масивна кровотеча після народження дівини через природні пологові шляхи. Дитяче місце та родові шляхи цілі. Дно матки — вище пупка, матка під час пальпації м'яка, не реагує на введення утеротоніків. Яка найімовірніша причина кровотечі?

- A. Гіпотонія матки
- B. Атонія матки
- C. Затримка частки плаценти
- D. Пошкодження шийки матки
- E. Розрив матки

109. Пацієнтка віком 24 роки скаржиться на підвищення температури тіла до  $38,4^\circ\text{C}$ , біль у попереку. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися після переохолодження. Об'єктивно спостерігається: ЧСС — 90/хв, АТ — 115/90 мм рт. ст. Симптом Пастернацького позитивний з обох боків. В аналізі крові: лейкоцити —  $10,6 \cdot 10^9/\text{л}$ , тромбоцити —  $150 \cdot 10^9/\text{л}$ , ШОЕ — 31 мм/год. В аналізі сечі: білок — 0,64 г/л, еритроцити змінені — 4-6 в полі зору, лейкоцити — густо покривають все поле зору, багато бактерій. Який найімовірніший діагноз?

- A. Геморагічний васкуліт
- B. Гострий пієлонефрит
- C. Системний червоний вовчак
- D. Сечокам'яна хвороба
- E. Гострий гломерулонефрит

110. Пацієнтка віком 44 роки скаржиться на постійний пекучий біль, почервоніння шкіри та набряк у ділянці лівої гомілки, загальне нездужання, озноб, підвищення температури тіла до  $39^\circ\text{C}$ . Початок захворювання пов'язує з подряпиною шкіри лівої гомілки, який стався 2 дні тому. Об'єктивно виявлено: в середній третині лівої гомілки спостерігається яскрава гіперемія шкіри, що має чіткі межі та підвищується над незмінною шкірою. Виявлено помірний набряк м'яких тканин, їхня болючість під час пальпації, у центрі гіперемованої шкіри — струн 2х0,2 см, що покриває поверхневу ранку. Яке ускладнення мікротравми лівої гомілки спостерігається в пацієнтки?

- A. Флегмона
- B. Гострий тромбофлебіт глибоких вен
- C. Гострий гнійний остеомиєліт
- D. Бешіха
- E. Газова гангрена

111. Пацієнтка віком 25 років скаржиться на загальну слабкість, сонливість, зниження працездатності, запаморочення, утруднення ковтання їжі, сухість шкіри та випадіння волосся, ламкість нігтів. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви та видимі слизові оболонки бліді, нігті ламкі, поперечно посмуговані. Дефіцит якого нутрієнта зумовив виникнення цього стану в жінки?

- A. Вітаміну D
- B. Фосфору
- C. Калію
- D. Заліза
- E. Вітаміну B<sub>6</sub>

112. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на схуднення, біль у нижній частині живота, випорожнення з домішками слизу та крові до 12-ти разів на добу. Під час фіброколоноскопії виявлено: у ділянці сигмовидної кишки візуалізуються локальні псевдополіпозні розростання, плоскі поверхневі виразкові ділянки неправильної форми, що не зливаються, вкриті слизом та фібрином, контактна кровоточивість. Який найімовірніший діагноз?

- A. Черевний тиф
- B. Хвороба Крона
- C. Псевдомембранозний коліт
- D. Хвороба Гіршпрунга
- E. Виразковий коліт

113. У п'ятирічної дитини через 2 тижні після перенесеної краснухи з'явилися носові кровотечі, петехіальний висип на шкірі та слизових оболонках різної форми та кольору, що зникає під час натискування. В аналізі крові: тромбоцити —  $50 \cdot 10^9/\text{л}$ . Який найімовірніший діагноз?

- A. Тромбоцитопенічна пурпура
- B. Гемофілія
- C. ДВЗ-синдром
- D. Системний червоний вовчак
- E. Геморагічний васкуліт

114. У військового під час бою з'явився стан знерухомлення, мутизм, вербальний контакт із ним неможливий, за тактильного контакту афект страху посилюється. Об'єктивно спостерігається: на обличчі вираз страху, не рухається, погляд фіксований в одній точці, на питання не відповідає. Який найімовірніший діагноз?

- A. Депресивний розлад
- B. Гострий реактивний ступор
- C. Соматизований розлад
- D. Іпохондричний розлад
- E. Посттравматичний стресовий розлад

115. Пацієнт віком 19 років скаржиться на набряки гомілок, обличчя, помірний біль у попереку, підвищення АТ до 180/100 мм рт.



ст. Із анамнезу відомо, що 2 тижні тому перхворів на гострий тонзиліт. У загальному аналізі сечі: протеїнурія — 1,2 г/добу, еритроцити покривають усе поле зору, еритроцитарні циліндри — 5-7 у полі зору. Який найімовірніший діагноз?

- A. Хронічний гломерулонефрит
- B. Хронічний пієлонефрит
- C. Гострий пієлонефрит
- D. Сечокам'яна хвороба
- E. Гострий гломерулонефрит

116. У чотирирічного хлопчика протягом 2-х днів спостерігаються такі симптоми: на тулубі, розгинальних поверхнях кінцівок — яскравий дрібно-плямистий висип на незміненому фоні шкіри без тенденції до злиття, збільшені потиличні та задньо-шийні лімфатичні вузли, температура тіла — 38°C. Із анамнезу відомо, що хлопчик не вакцинований. Який найімовірніший діагноз?

- A. Кір
- B. Краснуха
- C. Вітряна віспа
- D. Інфекційний мононуклеоз
- E. Скарлатина

117. У п'ятирічної дівчинки на 5-й день захворювання на ГРВІ виникли багаторазове блювання, втрата свідомості. Із анамнезу відомо, що мати неконтрольовано давала дитині ацетилсаліцилову кислоту та метамізол натрію. Об'єктивно спостерігається: за шкалою ком Глазго — 5-6 балів, геморагічний синдром, гепатомегалія, АТ — 100/60 мм рт. ст. В аналізі крові виявлено: гіпоглікемія, рівні білірубину та креатиніну в нормі, гіперамоніємія, підвищення рівнів АЛАТ та АсАТ у 10 разів, зниження протромбінового індексу та рівня альбуміну. Який невідкладний стан виник у дитини?

- A. Кетоацидотична кома
- B. Гостра печінкова недостатність
- C. Анафілактичний шок
- D. Гостра ниркова недостатність
- E. Гостра надниркова недостатність

118. Пацієнта віком 52 роки шпиталізовано зі скаргами на різку слабкість, запаморочення, втрату свідомості, схуднення, відсутність апетиту, нудоту та блювання, різкий біль в епігастральній ділянці, діарею та посилену пігментацію шкіри. АТ — 90/60 мм рт. ст. Який найімовірніший діагноз?

- A. Аддисонічна криза
- B. Системна склеродермія
- C. Менінгоенцефаліт
- D. Пелагра
- E. Гострий гастроентерит

119. У жінки віком 32 роки, у терміні вагітності 39 тижнів, 2 год тому розпочалися першими частотою 2 за 10 хвилин, тривалістю по 20-30 с. Об'єктивно спостерігається: серцебиття плода звучне, ритмічне — 136/хв, на великих статевих губах та промежині — декілька везикул, схожих на герпетичні. Поді-

бні висипання були і до вагітності 4-5 разів на рік, які пацієнтка пов'язувала із порушеннями гігієни, тому до лікарів не зверталася. Під час піхвового обстеження виявлено: шийка матки згладжена, відкриття на 4 см, плідний міхур цілий, голівка в I площині таза. Яка тактика ведення цієї вагітної?

- A. Пологи вести консервативно
- B. Вкоротити другий період пологів шляхом накладання вакуум-екстрактора
- C. Кесарів розтин
- D. Пологи вести консервативно, призначити ацикловір
- E. Пологи вести консервативно, обробити промежину антисептиком

120. Пацієнтка віком 38 років скаржиться на швидку стомлюваність, виражену слабкість у проксимальних м'язах кінцівок, судомні посмикування м'язів гомілок, головний біль. Об'єктивно спостерігається: ІМТ — 27 кг/м<sup>2</sup>, АТ — 180/100 мм рт. ст., пульс — 90/хв. В аналізі крові: низький рівень реніну, калій — 2,6 ммоль/л. Який найімовірніший діагноз?

- A. Первинний альдостеронізм
- B. Хвороба Іценко-Кушинга
- C. Тиреотоксикоз
- D. Есенціальна артеріальна гіпертензія
- E. Феохромоцитома

121. Пацієнтка віком 32 роки з приводу негоспітальної пневмонії приймає цефотаксим. На 5-й день лікування з'явилися водянисті випорожнення до 8-10 разів на добу, іноді з домішками свіжої крові в калі, спазматичний біль у нижніх квадрантах живота, здуття і бурчання в животі, підвищення температури тіла до 38,3°C. Який збудник, найімовірніше, спричинив погіршення стану пацієнтки?

- A. *Entamoeba histolytica*
- B. *Shigella flexneri*
- C. *Clostridioides difficile*
- D. *Enterobacter aerogenes*
- E. *Salmonella enterica*

122. Батьки хлопчика (вік — 1 рік 7 місяців) скаржаться на підвищення температури тіла в дитини до 39,2°C, відмову від їжі, але не від пиття. Із анамнезу відомо, що дитина була цілком здорова та не хворіла до цього часу. Об'єктивно спостерігається: гіперемія слизової оболонки ротоглотки, множинні везикули та дрібні (до 2 мм) срозії на слизовій оболонці піднебінних мигдаликів, м'якого піднебіння та язичка. Інших патологічних змін не знайдено. Який збудник, найімовірніше, викликав інфекцію в дитини?

- A. Вірус Епштейна-Барр
- B. Вірус грипу
- C. Вірус Коксаки
- D. Аденовірус
- E. Вірус простого герпесу

123. Унаслідок ДТП 11 пасажирів автобуса отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Під час рятувальних робіт виявлено, що в одного із постраждалих з відкритої



рани плеча витікає кров яскраво-червоного кольору. Частота дихання 6 за хвилину, реагує на біль, пульс на периферійних судинах не визначається. До якої сортувальної групи за ознаками здоров'я та потребою в однорідних лікувальних та евакуаційних заходах належить потерпілий?

- А. Жовтої
- В. Червоної
- С. Чорної
- Д. Зеленої
- Е. —

124. Пацієнт віком 27 років скаржиться на озноб, нестерпний головний біль, біль у м'язах та під час руху очима, світлочутливість, різку слабкість. Об'єктивно спостерігається: шкіра та видимі слизові оболонки гіперемовані, гарячі та вологі на дотик, язик сухий, обкладений білим нальотом, температура тіла — 39,8°C, на шкірі бічних поверхонь тулуба, під пахвами, на спині та кінцівках візуалізується розеолезно-петехіальний висип, ЧСС — 98/хв, АТ — 130/70 мм рт. ст., печінка і селезінка помірно збільшені, безболісні під час пальпації. Позитивні симптоми Кіарі, Розенберга, Говорова-Гудельє. Аускультативно: вислуховуються поодинокі сухі хрипи над легеньми, тони серця послаблені. Який найімовірніший діагноз?

- А. Лептоспіроз
- В. Малярія
- С. Висипний тиф
- Д. Грип
- Е. Черевний тиф

125. У пацієнта віком 29 років ввечері раптово з'явився ниючий біль постійного характеру в епігастральній ділянці. За дві години виникла нудота, було одноразове блювання. До ранку біль став різким і перемістився в праву клубову ділянку. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 37,6°C, ЧСС — 90/хв. Під час пальпації виявлено: болючість та напруження м'язів передньої черевної стінки в правій клубовій ділянці, позитивний симптом Воскресенського. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гострий апендицит
- В. Жовчнокам'яна хвороба
- С. Гострий панкреатит
- Д. Перфоративна виразка шлунка
- Е. Гостра кишкова непрохідність

126. Під час поточного санітарного обстеження терапевтичного відділення лікарні проведено визначення показників мікроклімату у палатах. Результати вимірювань: середня температура повітря — 20°C, перепад температури по вертикалі — 2°C, по горизонталі — 1°C, швидкість руху повітря — 0,15 м/с, відносна вологість повітря — 55%. Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату палат.

- А. Дискомфортний із підвищеною вологістю повітря
- В. Комфортний
- С. Дискомфортний із підвищеною швидкістю руху повітря
- Д. Дискомфортний нагрівного типу
- Е. Дискомфортний охолоджувального типу

127. Пацієнт віком 75 років скаржиться на часте сечовипускання (4-5 разів за ніч), стоншення струменя сечі. Під час пальпаторного дослідження передміхурової залози виявлено: розмір — 4х6 см, туго-еластичної консистенції, з чіткими контурами, гладенька. Результати урофлоуметрії — 42 мл/с. Під час УЗД спостерігається: у просвіті сечового міхура додаткове утворення з чіткими контурами. Залишкової сечі — 100 мл. Який найімовірніший діагноз?

- А. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози
- В. Склероз простати
- С. Рак сечового міхура
- Д. Рак простати
- Е. Хронічний простатит

128. Пацієнт віком 26 років скаржиться на набряк повік, утруднене дихання. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися на 3-й день після початку прийому антибіотиків, хворіє на поліноз. Об'єктивно спостерігається: гіперемія червоної облямівки губ, гіперемія та набряк повік, м'якого піднебіння, язичка та піднебінних мигдаликів. Аускультативно: везикулярне дихання. Який найімовірніший діагноз?

- А. Інфекційний мононуклеоз
- В. Кропив'янка
- С. Бронхіальна астма
- Д. Набряк Квінке
- Е. Гострий герпетичний хейліт

129. Пацієнтка віком 60 років скаржиться на незначні кров'янисті виділення зі статевих шляхів, що з'явилися після 4-х років менопаузи. Під час бімануального дослідження виявлено: шийка матки циліндричної форми, епітелій цілий. Матка в антефлексію, дещо збільшена в розмірах, рухома. Додатки матки не пальпуються, виділення геморагічні. Під час діагностичного вишкрібання порожнини матки отримано мозкоподібний зішкріб. Який найімовірніший діагноз?

- А. Рак тіла матки
- В. Клімактерична кровотеча
- С. Аденоміоз матки
- Д. Дисфункціональна маткова кровотеча
- Е. Лейоміома матки

130. У пацієнтки віком 38 років спостерігається нападоподібне підвищення артеріального тиску до 235/120 мм рт. ст. Під час нападу пацієнтка скаржиться на нудоту, блювання, тахікардію, пітливість, страх смерті, головний біль, задишку, тремор рук і блідість шкіри. Напади починаються раптово та тривають 20-40 хв. У крові під час нападу спостерігається: лейкоцитоз з еозинофілією, глюко-



за крові — 6,3 ммоль/л. Напад закінчується поліурією, після чого пацієнтка відзначає сонливість, почервоніння шкіри, тривалий час зберігається загальна слабкість. Який найімовірніший діагноз?

- А. Феохромоцитома
- В. Гіпертиреоз
- С. Цукровий діабет
- Д. Первинний гіперальдостеронізм
- Е. Хвороба Іценко-Кушинга

131. Пацієнт віком 45 років скаржиться на переймоподібний біль у животі, тенезми, часті рідкі випорожнення з домішками крові. Хворіє протягом 5-ти років. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 37,5°C, АТ — 110/60 мм рт. ст., пульс — 98/хв, живіт м'який, болючий під час пальпації по ходу товстої кишки. За результатами іригоскопії виявлено: товста кишка звужена, гаустри відсутні, контури нерівні, нечіткі. У загальному аналізі крові виявлено: еритроцити —  $3,2 \cdot 10^{12}/л$ , гемоглобін — 110 г/л, КП — 0,85, лейкоцити —  $8,1 \cdot 10^9/л$ , паличкоядерні нейтрофіли — 5%, лімфоцити — 30%, моноцити — 3%, еозинофіли — 3%, сегментоядерні нейтрофіли — 59%, ШОЕ — 24 мм/год. Фекальний кальпротектин — 95 Од. Який лікарський засіб необхідно призначити першочергово в цьому разі?

- А. Панкреатин
- В. Месалазин
- С. Дротаверин
- Д. Ципрофлоксацин
- Е. Лоперамід

132. Пацієнт віком 26 років скаржиться на висип у ділянці обличчя, свербіж, жар, біль. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом двох років. Об'єктивно спостерігається: на шкірі обличчя в ділянці підборіддя — інфільтровані ділянки яскраво-червоного кольору, засіяні пустулами та кірками, з численними ерозіями, по периферії розташовані папуло-пустульозні елементи. Який найімовірніший діагноз?

- А. Звичайні вугри
- В. Екзема
- С. Контактний дерматит
- Д. Сикоз
- Е. Короста

133. У пацієнтки віком 28 років на 14-й день 28-денного менструального циклу з'явився різкий біль униз живота праворуч, із запамороченням. Об'єктивно спостерігається: шкіра та слизові оболонки бліді, пульс — 100/хв, АТ — 100/70 мм рт. ст. Під час бімакуального дослідження виявлено: склепіння нависають, правий яєчник збільшений до 3x5 см, пастозний, болючий під час пальпації. Який найімовірніший діагноз?

- А. Порушена правостороння трубина вагітність
- В. Гострий апендицит
- С. Аномальна маткова кровотеча
- Д. Перекрут ніжки кісти правого яєчника
- Е. Апоплексія правого яєчника

134. Пацієнт із вивихом плеча скаржиться на відчуття оніміння в пальцях кисті. Об'єктивно спостерігається: обмежене активне відведення I пальця. Який нерв пошкоджено в пацієнта?

- А. Ліктьовий
- В. Шкірний
- С. Серединний
- Д. Промієвий
- Е. Плечовий

135. Пацієнтка віком 42 роки скаржиться на рясні та тривалі менструації упродовж останніх 6-ти місяців. В анамнезі: пологи — 1, штучний аборт — 1. За результатами гінекологічного обстеження виявлено: шийка матки без дефектів епітелію, виділення слизові помірні, тіло матки та придатки нормальних розмірів, безболісні. За результатами УЗД виявлено: товщина ендометрія — 17 мм. Який метод дослідження найінформативніший для встановлення діагнозу в цьому разі?

- А. Гістероскопія
- В. Гістологічне дослідження пайпель-аспірату з порожнини матки
- С. Діагностичне вишкрібання порожнини матки
- Д. Цитологічне дослідження пайпель-аспірату з порожнини матки
- Е. Визначення онкомаркерів

136. Пацієнтка віком 30 років скаржиться на слабкість, швидку стомлюваність, біль та набряклість у суглобах. Із анамнезу відомо, що скарги виникли після відпочинку на морі, через 2 тижні підвищилася температура тіла до 38°C та виникла стійка гіперемія обличчя з елементами еритематозного висипу. У загальному аналізі крові: анемія, лейкопенія, лімфопенія, тромбоцитопенія. В аналізі сечі: протеїнурія. Який найімовірніший діагноз?

- А. Атопічний дерматит
- В. Ревматоїдний артрит
- С. Реактивний артрит
- Д. Системний червоний вовчак
- Е. Гострий лейкоз

137. Пацієнт віком 68 років, що лікувався в стаціонарі з приводу нестабільної стенокардії, під час ходіння раптово втратив свідомість, упав. Об'єктивно спостерігається: пульсація на артеріях відсутня, зіниці вузькі, на світло не реагують, рідкі малоамплітудні рухи грудної клітки — до 8-10/хв, АТ не визначається. На ЕКГ виявлено: синусоїдна крива з частими, різними за формою і амплітудою хвилями частотою 350-400/хв. Яке ускладнення виникло у пацієнта?



- А. Фібриляція шлуночків
- В. Тромбоемболія легеневої артерії
- С. Фібриляція передсердь
- Д. Повна атріовентрикулярна блокада
- Е. Асистолія

138. Серед усіх зареєстрованих захворювань населення, що обслуговується поліклінікою міста, пацієнти з цукровим діабетом становлять 21%. Який статистичний показник наведено?

- А. Наочності
- В. Кореляції
- С. Співвідношення
- Д. Екстенсивний
- Е. Інтенсивний

139. У дворічної дитини спостерігаються вздуття живота та закрепи. Із анамнезу відомо, що симптоми з'явилися в дев'ятимісячному віці. Під час іригографії виявлено: звуження зона у дистальних відділах товстої кишки з воронкоподібним переходом у супрастенотичне розширення. Який найімовірніший діагноз?

- А. Хвороба Гіршпрунга
- В. Хвороба Крона
- С. Подвоєння кишечника
- Д. Доліхосигма
- Е. Дивертикул Меккеля

140. Вагітну жінку віком 22 роки шпиталізовано в тяжкому стані зі скаргами на появу набряків, головний біль, нудоту, одноразове блювання. Об'єктивно спостерігається: свідомість потьмарена, АТ — 160/130 мм рт. ст., дрібні фібрилярні посмикування м'язів обличчя, утруднене носове дихання. Під час транспортування почалося посмикування верхніх кінцівок, тіло жінки витяглося, хребет вигнувся, щелепи щільно стиснулися, дихання припинилося. Після цього з'явилися клонічні судоми, виражений ціаноз. Потім судоми припинилися, з'явився глибокий шумний вдих, на губах виступила піна, забарвлена кров'ю. Який найімовірніший діагноз?

- А. Гіпертонічний криз
- В. Епілепсія
- С. Діабетична кома
- Д. Екламсія
- Е. Хорея

141. Восьмирічна дівчинка скаржиться на слабкість, кашель, головний біль, сльозотечу, появу висипу. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 39,2°C, кон'юнктивіт, нежить, яскрава гіперемія задньої стінки глотки, на слизовій оболонці щік — дрібний поодинокий висип білуватого кольору, на обличчі, шиї та грудях — макулопапульозний висип. Який найімовірніший діагноз?

- А. Скарлатина
- В. Краснуха
- С. Менінгококцемія
- Д. Інфекційний мононуклеоз
- Е. Кір

142. Пацієнт віком 30 років скаржиться на свербіж шкіри, що посилюється ввечері. Із анамнезу відомо, що хворіє протягом 1,5 місяця. Об'єктивно спостерігається: на шкірі міжпальцевих складок кистей, згинальних поверхнях кінцівок, животі, стегнах, сідницях візуалізується висип, що складається з парних папул, покритих кров'янистими кірочками, лінійні розчухи. Який найімовірніший діагноз?

- А. Короста
- В. Кропив'янка
- С. Істинна екзема
- Д. Псоріаз
- Е. Контактний дерматит

143. Жінку віком 25 років шпиталізовано до пологового будинку зі скаргами на підтікання прозорих навколоплідних вод. Із анамнезу відомо, що вагітність перша, 27 тижнів. Об'єктивно спостерігається: стан задовільний, температура тіла — 36,6°C, пульс — 68/хв, матка в нормальному тонусі, ВДМ — 26 см, ОЖ — 80 см, положення плода поздовжнє, серцебиття ясне, ритмічне — 138/хв. Під час огляду в дзеркала підтікають прозорі навколоплідні води. Обрана очікувальна тактика ведення вагітності. Проте через 3 доби у вагітної на тлі підвищення температури тіла до 37,3°C з'явилися скарги на рясні гнильні виділення. Тонус матки підвищений. Серцебиття плода — 168/хв. В аналізі крові: лейкоцитоз —  $15 \cdot 10^9/\text{л}$ . Як ускладнення розвинулося у вагітної?

- А. Хоріоамніоніт
- В. Ендометриоз
- С. Передчасні пологи
- Д. Дистрес плода
- Е. Передчасне відшарування плаценти

144. Восьмирічній дівчинці встановлено діагноз: гострий лімфобластний лейкоз. Відповідно до протоколу лікування введено циклофосфамід. Наступного дня в неї виникло блювання, що не припинялося протягом 4-х год. Який лікарський засіб необхідно призначити дівчинці для припинення блювання в цьому разі?

- А. Ондасетрон
- В. Налоксон
- С. Аскорбінову кислоту
- Д. Фолієву кислоту
- Е. Дрогаверин

145. Пацієнта віком 42 роки шпиталізовано до травматологічного відділення. Рентгенологічно виявлено перелом кісток таза. Об'єктивно спостерігається: самостійне сечовиділення відсутнє, уретрорагія. Пальпуються збільшений сечовий міхур і болісна припухлість у ділянці промежини. Який попередній діагноз?



- А. Рефлекторна затримка сечовивипускання
- В. Забій промежини
- С. Гостра ниркова недостатність
- Д. Травма сечового міхура
- Е. Травма уретри

**146.** Пацієнтка віком 35 років скаржиться на появу різкого болю в правій здухвинній ділянці, затримку менструації на 5 тижнів. Об'єктивно спостерігається: шкіра та слизові оболонки бліді, пульс — 104/хв, АТ — 80/60 мм рт. ст., симптоми подразнення очеревини різко позитивні. За результатами гінекологічного обстеження виявлено: слизова оболонка піхви та шийки матки ціанотична, зовнішній зів закритий, заднє склепіння навісає. Симптом Промітова різко позитивний. Під час пункції черевної порожнини через заднє склепіння піхви отримано рідку кров, що не згортається. Який найімовірніший діагноз?

- А. Рак ендометрія
- В. Перекрут ніжки пухлини яєчника
- С. Загострення хронічного аднекситу
- Д. Апоплексія правого яєчника
- Е. Порушена позаматкова вагітність праворуч

**147.** У загальноосвітньому навчальному закладі проводиться медичний огляд школярів. Вирішується питання щодо вибору методу оцінки фізичного розвитку учнів. Які переваги має метод оцінки за шкалами регресії у порівнянні з методом сигмальних відхилень?

- А. Кожен соматометричний показник оцінюється відокремлено і можна побудувати профіль фізичного розвитку
- В. Можна оцінити пропорційність фізичного розвитку
- С. Враховується кореляційна залежність між ростом, масою тіла та окружністю грудної клітки
- Д. Надає можливість оцінки біологічного і хронометражного віку та їх відповідність
- Е. Метод наочний і не потребує розрахунків

**148.** Медичний працівник загальноосвітньої школи на підставі довідки про стан здоров'я здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою. До якої групи належить учень 5 класу, який знаходиться в ре-

абілітаційному періоді після гострого бронхіту, що не потребує курсу лікувальної фізкультури із середнім рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи (індекс Руф'є — 7)?

- А. Ізольованої
- В. Підготовчої
- С. Основної
- Д. Додаткової
- Е. Спеціальної

**149.** У пацієнта віком 42 роки виявлено захворювання легень. З анамнезу відомо, що працює на підприємстві, у повітрі робочої зони якого концентрація діоксиду кремнію перевищує ГДК утричі. Яке професійне захворювання, найімовірніше, виникло у пацієнта?

- А. Силікатоз
- В. Антракоз
- С. Силікоз
- Д. Сидероз
- Е. Алюмініоз

**150.** Пацієнтка віком 72 роки скаржиться на головний біль, нудоту, блювання, загальну слабкість, набряклість обличчя, м'язову слабкість, ніктурію. В анамнезі: ІХС, СН, хронічний пієлонефрит, цукровий діабет 2-го типу, ожиріння. Об'єктивно спостерігається: шкіра світло-коричневого кольору, суха, холодна, АТ — 160/90 мм рт. ст., ЧСС — 72/хв, температура тіла — 36,2°C, дихання вільне, везикулярне, живіт м'який, безболісний. Симптом Пастернацького негативний. На ЕКГ: ритм синусовий, правильний, сегмент ST у всіх відведеннях на ізолнії, ЕВС зміщена ліворуч. В аналізі крові: гемоглобін — 94 г/л, еритроцити —  $3 \cdot 10^{12}/л$ , лейкоцити —  $5 \cdot 10^9/л$ , тромбоцити —  $210 \cdot 10^9/л$ . В аналізі сечі: відносна густина — 1,005, еритроцити — відсутні, лейкоцити — 1 у полі зору, білок — 0,8 г/л. Який найімовірніший діагноз?

- А. Синдром Гудпасчера
- В. Загострення хронічного пієлонефриту
- С. Сечокам'яна хвороба
- Д. Хронічна ниркова недостатність
- Е. Хронічна надниркова недостатність